

Vacinação do adulto · princípios

No adulto, foque em influenza anual, dT/dTpa, hepatite B, tríplice viral quando susceptível, pneumo e herpes zóster conforme idade/risco — e saiba contraindicações verdadeiras.

Vacinas frequentemente cobradas

- Hepatite B: 3 doses se não vacinado; checar anti-HBs em profissionais de saúde
- dT: reforço a cada 10 anos; dTpa em gestante (a cada gestação) e contatos do RN
- SCR (tríplice viral): 2 doses na vida se nascido após período de calendário / susceptível
- Influenza: anual, prioridade para grupos de risco e campanhas
- Febre amarela: conforme área e indicação; atenção a imunossuprimidos

Vivas vs inativadas

Tipo | Exemplos | Cuidado

Vivas atenuadas | SCR, FA, varicela | Evitar em gestação e imunossupressão grave

Inativadas / toxoides | Influenza, hepatite B, dT | Em geral seguras na gestação quando indicadas

Polissacarídicas / conjugadas | Pneumocócicas | Escolher esquema por idade/risco

Contra-indicações e falsos mitos

- Contraindicação verdadeira: anafilaxia a componente; imunossupressão grave para vacinas vivas
- Gestação: evitar vivas; dTpa e influenza são desejáveis
- Resfriado leve e uso de antibiótico NÃO contraindicam vacina
- Alergia a ovo: avaliar produto — muitas formulações de influenza são seguras com protocolo

Intervalos

Dica - Intervalos

Duas vacinas vivas injetáveis no mesmo dia OK; se não simultâneas, intervalo clássico de 28 dias. Inativadas podem ser no mesmo dia ou com qualquer intervalo.

Esquema mental por faixa etária e condição de risco (calendário PNI — conferir atualização).



Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

dTpa na gestante não é 'só se nunca tomou': indica-se a cada gestação (janela usual no 2º/3º trimestre) para proteger o RN contra coqueluche.